

居家康复项目治疗效果 临床患者案例——盆底康复

案例情况

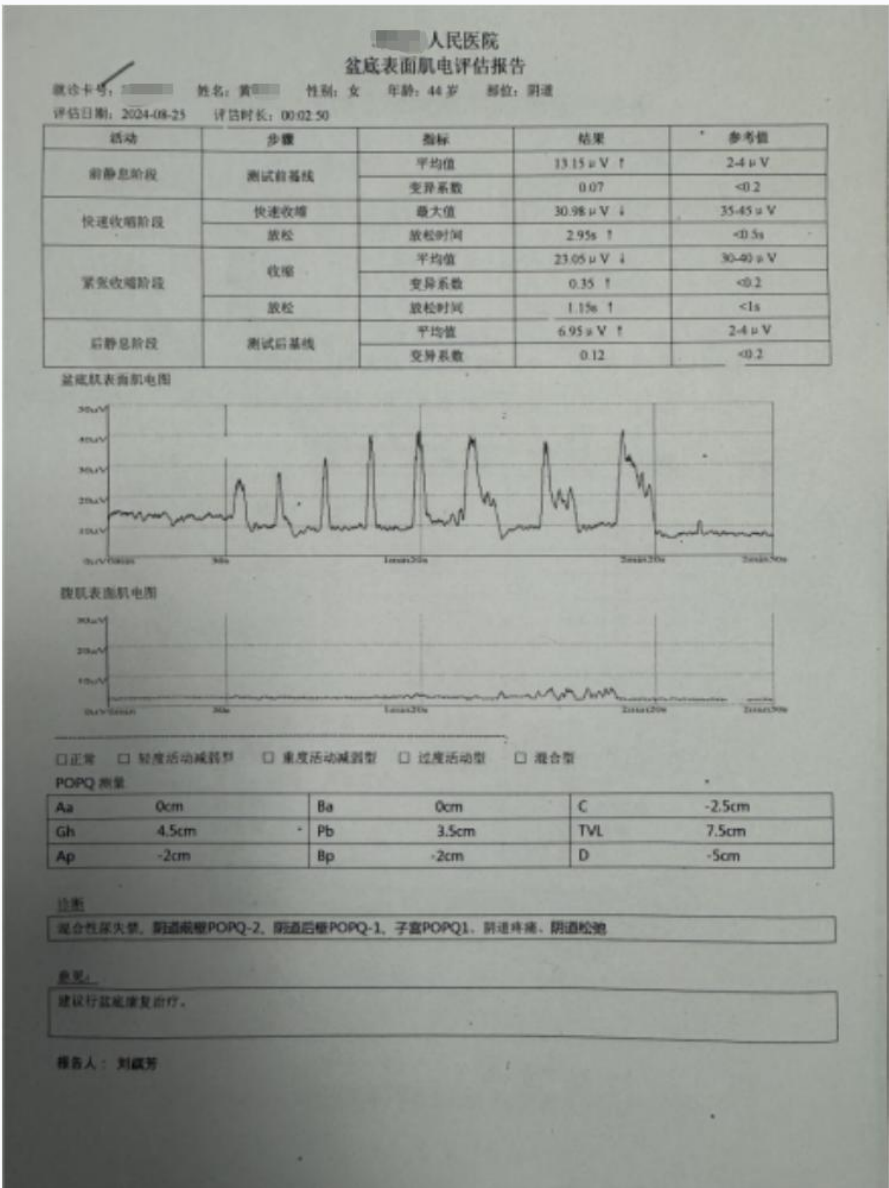
黄女士，44岁；

诊断内容：混合性尿失禁、阴道前壁POPQ-2、阴道后壁POPQ-1、子宫POPQ1、阴道疼痛、阴道松弛

症状分析：阴道疼痛导致盆底肌肉紧张，伴有尿频发生

治疗过程变化

一、8月27日第一次治疗后，用户反馈：当晚尿了4次，比平时多



医生建议：多做腹式呼吸放松一下盆底肌肉以及稍微调整一下方案：

原方案：

处方1：混合型尿失禁（逼尿肌活跃过度） 5μv	时长：10分钟
处方2：凯格尔僵肌 15μv	时长：10分钟
处方3：阴道痉挛（性交疼痛）	时长：10分钟
处方4：压力性尿失禁 5μv	时长：10分钟

修改后方案：

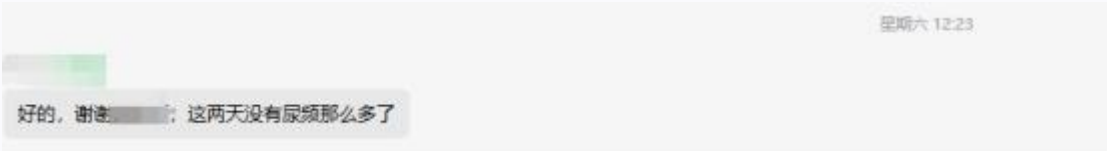
处方1：混合型尿失禁（逼尿肌活跃过度） 5μv	时长：10分钟
处方2：慢性盆腔疼痛	时长：10分钟
处方3：压力性尿失禁 5μv	时长：10分钟
处方4：阴道痉挛（性交疼痛）	时长：10分钟

二、8月29日，用户反馈腰痛是旧患，尿频比平时严重了



医生建议：自我治疗锻炼，叫做膀胱锻炼。可以适当的延长两次排尿间隔时间，比如说有排尿感了在延长15分钟左右再去上厕所，慢慢的延长。两次排尿时间不超过三小时。除外饮水量大或者有尿道炎的时候

三、8月31日，用户反馈近2天没有尿频那么多了



处方1：急性尿失禁 5μv	时长：10分钟
处方2：慢性盆腔疼痛	时长：10分钟
处方3：混合型尿失禁（逼尿肌活跃过度） 5μv	时长：10分钟
处方4：阴道痉挛（性交疼痛）	时长：10分钟

处方1：混合型尿失禁（逼尿肌活跃过度） 5μv	时长：10分钟
处方2：慢性盆腔疼痛	时长：10分钟
处方3：压力性尿失禁 5μv	时长：10分钟
处方4：阴道痉挛（性交疼痛）	时长：10分钟

案例情况

谢女士，38岁

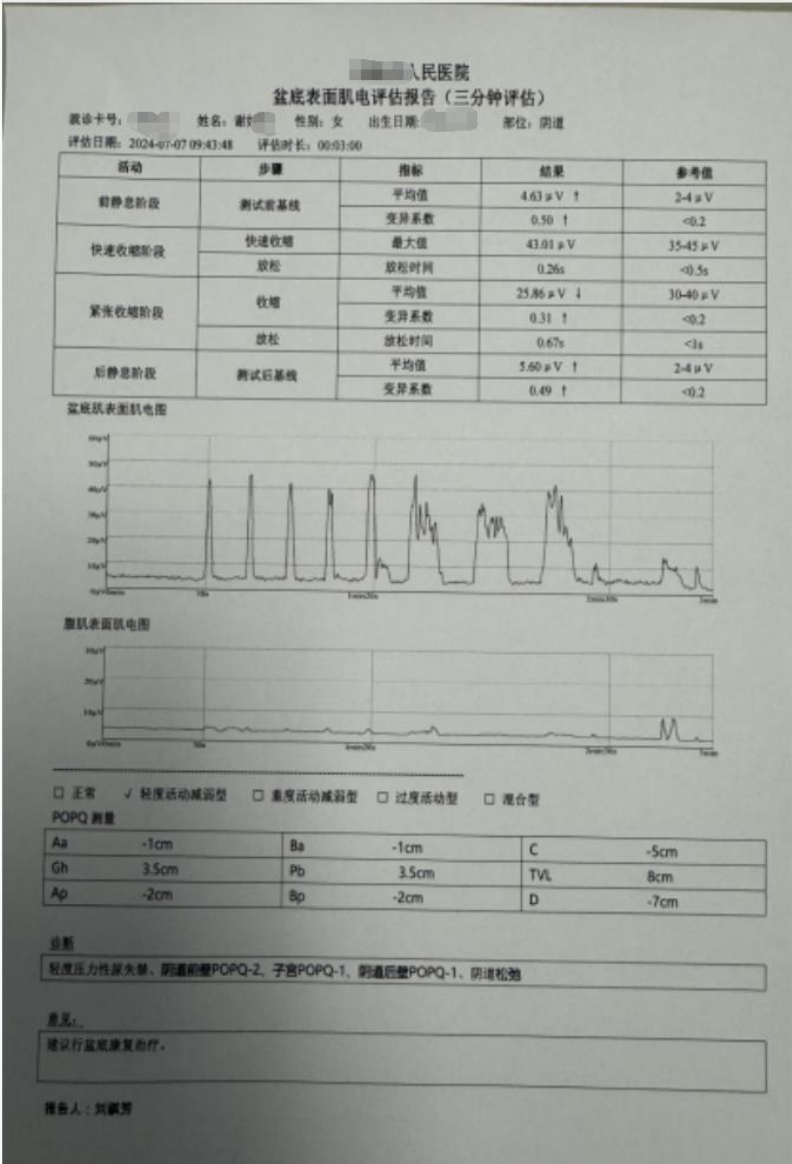
诊断内容：轻度压力性尿失禁、阴道前壁POPQ-2、子宫POPQ-1、阴道后壁POPQ-1、阴道松弛

治疗过程变化

前期，紧张收缩,耐力收缩幅值降低，耐力收缩稳定性差

第四次评估截图可以看出：基线完全正常了，肌力也有提高。

医生建议：需要慢慢练习，反复纠正：在阴道收缩保持的时候尽量同一个力度收紧，且需要正常呼吸以及不借力。可以心里默数数字，在不憋气和不借力的前提下尽量保持前3秒，后面实在保持不了了可以放松，3秒很熟练的保持后我们就练习保持4秒，循序渐进。



用户反馈

2024年8月17日 17:00

感谢您的帮助，自己明细感觉好了很多

2024年8月17日 17:09

您的健康是我们最大的期盼，您的鼓励
给了我们前进的动力，谢谢❤️

案例情况

刘女士，30岁；

诊断内容：8月9日：中度压力性尿失禁、阴道后壁POPQ-1、阴道前壁POPQ-1、阴道松弛、腹直肌分离(4.5cm)；

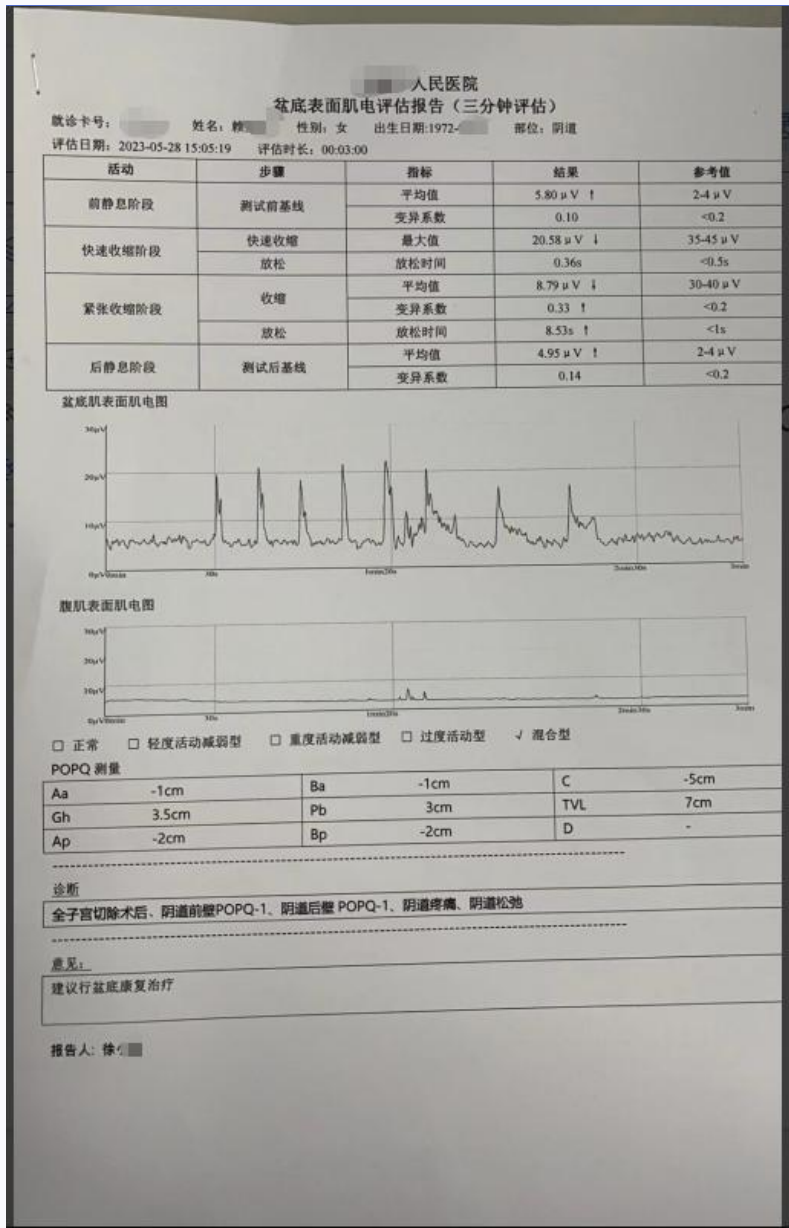
9月2日：腹直肌分离(4cm)、阴道前壁 POPQ-1、阴道后壁 POPQ-1、子宫 POPQ-1、盆腹收缩不协调。

治疗过程变化

8月15日评估后医生建议：每一次治疗和锻炼后，都要进行10-15分钟腹式呼吸放松一下。

8月27日评估后医生反馈：基线已经完全降到正常了。需要注意的是，每一次收缩结束后都要尽量放松不用力。

9月2日复查后医生诊断：盆底恢复可以，行腹直肌治疗。



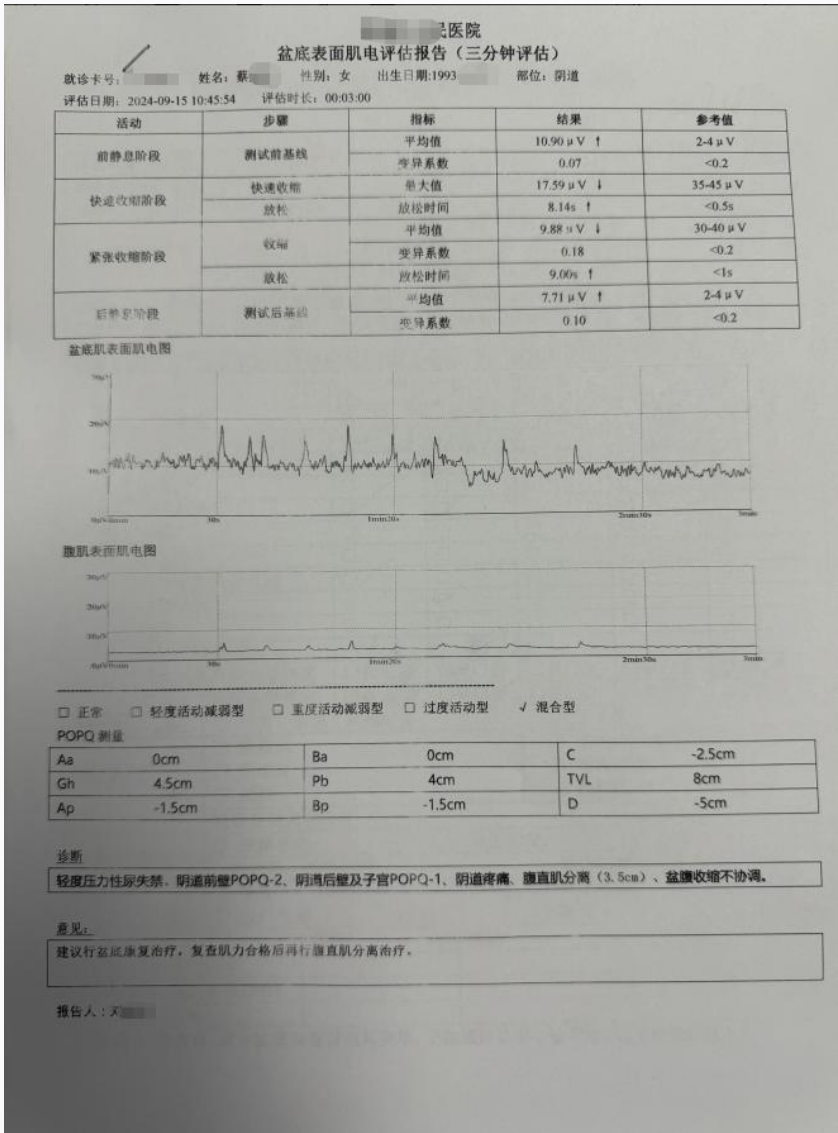
案例情况

赖女士，52岁

诊断内容：全子宫切除术后、阴道前壁POPQ-1、
阴道后壁POPQ-1、阴道疼痛、阴道松弛

治疗过程变化

肌力明显提升，稳定性加强。



案例情况

蔡女士，30岁；

诊断内容：轻度压力性尿失禁、阴道前壁POPQ-2、阴道后壁及子宫POPQ-1、阴道疼痛、腹直肌分离
症状描述：收缩10秒很难做，换气的时候觉得很短，肌肉不受控制，感觉降不下来，不知道怎么放松

治疗过程变化

10月12日 13:45

微信

。这几天不太舒服。会推迟几天再做仪器治疗@盆底康复 刘医生

10月12日 14:15

微信

好的

微信

好好休息

10月12日 14:34

微信

谢谢

微信

我感觉 仪器+运动。还是有效果的

微信

最起码盆底肌肉。自己感觉有点力了

9月19日 10:48

微信

刘医生。我想问一下。测试前调的电流是用来衡量什么的呀？@盆底康复 刘医生

微信

我今天做完第三次了。感觉同样55的电流。这次肌肉貌似更有感觉了

微信

前两次好像比较麻木

9月19日 11:19

微信

魏婉慧：
刘医生。我想问一下。测试前调的电流是用来衡量什么的呀？@盆底康复 刘医生
测试前的电流量？

微信

是的

微信

我们测试是没有电流感的。只有治疗的时候才需要调节电流量的大小。调节电流量是为了您在治疗时候的电流量根据您的事先调节好值定一个比较舒适的值。不需要反复的调节。

微信

当然。在治疗的时候也可以根据当时感觉调节电流量的大小。每次电流量不用参考前次的值。根据当时情况调节到舒适明显状态就可以了

案例情况

郭女士；

诊断内容：中度压力性尿失禁、阴道前壁POPQ-2、子宫 POPQ-1、阴道后壁POPQ-1、阴道松弛

治疗过程变化

郭女士 盆底治疗群

由微信用户创建的外部群，含5位外部联系人，群主：客服媛媛(客服媛媛)

好的

我也感觉好多了

👍👍👍

星期三 16:04

郭女士 盆底治疗群

由微信用户创建的外部群，含5位外部联系人，群主：客服媛媛(客服媛媛)

肌力有进步，继续坚持锻炼，每天坚持做Kege训练2-3次，一次10-15分钟，做完训练后做腹式呼吸放松一下

好的

我也感觉好多了

👍👍👍

进步很大。

治疗方案适合😊

星期三 16:31

无医院妇科盆底
盆底表面肌电评估报告（三分钟评估）

诊卡号： 姓名：郭 性别：女 出生日期： 部位：阴道
评估日期：2024-10-04 09:34:59 评估时长：00:03:00

活动	步骤	指标	结果	参考值
前静息阶段	测试前基线	平均值	2.56 μ V	2-4 μ V
		变异系数	0.17	<0.2
快速收缩阶段	快速收缩	最大值	40.66 μ V	35-45 μ V
	放松	放松时间	0.28s	<0.5s
紧张收缩阶段	收缩	平均值	27.75 μ V ↓	30-40 μ V
	放松	变异系数	0.20 ↑	<0.2
后静息阶段	测试后基线	平均值	2.47s ↑	<3s
		变异系数	3.01 μ V	2-4 μ V
		变异系数	0.09	<0.2

盆底肌表面肌电图

腹肌表面肌电图

☐ 正常 ☒ 轻度活动减弱型 ☐ 重度活动减弱型 ☐ 过度活动型 ☐ 混合型

POPQ测量		Ba	0cm	C	-5cm
Aa	0cm	Pb	4.5cm	TVL	7cm
Gh	3cm	Bp	-2cm	D	-6.5cm
Ap	-2cm				

诊断

中度压力性尿失禁、阴道前壁POPQ-2、子宫 POPQ-1、阴道后壁POPQ-1、阴道松弛

意见

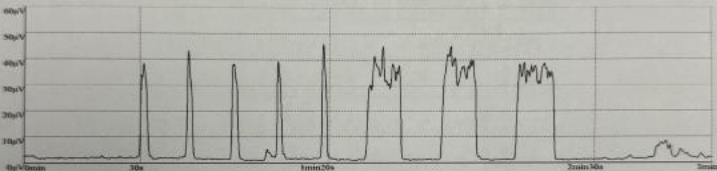
建议行盆底康复治疗。

报告人：韩

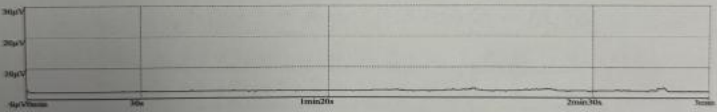
民医院妇科盆底
盆底表面肌电评估报告（三分钟评估）
就诊卡号： 姓名：戴 性别：女 出生日期：1986 部位：阴道
评估日期：2024-09-27 09:02:04 评估时长：00:03:00

活动	步骤	指标	结果	参考值
前静息阶段	测试前基线	平均值	2.16 μ V	2-4 μ V
		变异系数	0.37 $\uparrow$	<0.2
快速收缩阶段	快速收缩	最大值	40.98 μ V	35-45 μ V
	放松	放松时间	0.26s	<0.5s
紧张收缩阶段	收缩	平均值	32.49 μ V	30-40 μ V
	放松	变异系数	0.28 $\uparrow$	<0.2
后静息阶段	测试后基线	平均值	2.75 μ V	2-4 μ V
		变异系数	0.67 $\uparrow$	<0.2

盆底肌表面肌电图



腹肌表面肌电图



√ 正常 ☐ 轻度活动减弱型 ☐ 重度活动减弱型 ☐ 过度活动型 ☐ 混合型

POPQ 测量

Aa	-1cm	Ba	-1cm	C	-3cm
Gh	4cm	Pb	4.5cm	TVL	7.5cm
Ap	-2cm	Bp	-2cm	D	-5.5cm

诊断

阴道前壁POPQ-2、子宫POPQ-1、阴道后壁POPQ-1、阴道松弛

意见：

建议继续盆底康复治疗。

报告人：刘

案例情况

戴女士，38岁；

诊断内容：阴道前壁POPQ-2、子宫POPQ-1、阴道后壁POPQ-1、阴道松弛

症状分析：经常小便完站起来还想，尿不尽，耻骨痛

治疗过程变化

